

Hechos, inferencias e incertidumbre

Metacognición, lenguaje y decisión clínica — dossier para prólogo

Autor: Daniel Opazo · **Género:** ensayo médico-epistemológico con herramientas aplicadas · **Extensión:** ~32.400 palabras (110 páginas A4 en manuscrito) · **Estado:** edición de trabajo revisada, 2026 · **Público:** médicos clínicos y residentes; legible por todo profesional de la salud.

La tesis en tres frases

El conocimiento clínico está compuesto por hechos incompletos, inferencias graduadas e incertidumbre irreductible. La inteligencia médica consiste en distinguirlos, integrarlos y decidir sin convertir la probabilidad en certeza. El lenguaje clínico —la frase de la ficha, la presentación en el pase de visita— es el instrumento donde esa distinción se conserva o se destruye.

Qué lo diferencia

- **Es operativo, no contemplativo.** Cada capítulo termina en herramienta: un léxico de certeza con usos correctos e incorrectos, el método HII-D (hechos-inferencias-incertidumbre-decisión, con versión de 60 segundos), 12 talleres que reescriben notas clínicas reales, una guía de implementación para servicios.
- **Está centrado en la escritura clínica,** un ángulo que Groopman, Croskerry y la literatura de sesgos no cubren: la evolución, la epicrisis y el pase de turno como tecnología del pensamiento colectivo.
- **Toma posición en los debates vivos** — declara explícitamente su lugar en la controversia Croskerry vs. Norman/Monteiro sobre si puede enseñarse a “pensar mejor”, y fundamenta los umbrales de decisión en el riesgo inductivo (Rudner, Douglas).
- **Modela lo que predica:** presenta HII-D como heurística no validada, formula qué evidencia obligaría a abandonarlo, y declara el uso de asistencia de IA en su elaboración.
- **Un caso longitudinal** (una paciente con obstrucciones intestinales recurrentes) atraviesa el libro completo, del ingreso a la decisión compartida, y un cuaderno de ocho viñetas —de la urgencia a las 3 AM al final de la vida— aplica el método.
- **Escrito en español desde la práctica hispanoamericana,** no traducido.

Índice condensado

- **Parte I. Las capas del conocimiento clínico** — el hecho y su procedencia; la inferencia abductiva; la taxonomía de la incertidumbre; lenguaje y densidad epistémica.
- **Parte II. La mente que se observa** — metacognición y calibración; pericia e intuición; error como trayectoria (con un error del autor analizado); desaceleración selectiva.
- **Parte III. Decidir en el tiempo y con otros** — evidencia poblacional y umbrales; temporalidad y contrafactuales; la ficha como instrumento de pensamiento; equipos, desacuerdo y comunicación de incertidumbre.
- **Parte IV. Una epistemología operativa** — IA como espejo del razonamiento; humildad epistémica y responsabilidad; el método HII-D y su falsabilidad; cuaderno de ocho casos; enseñar y organizar la metacognición clínica.
- Apéndices: hoja HII-D · léxico de certeza · guía de implementación en servicio · glosario · índice analítico · ~85 referencias (de Peirce y Polanyi a Fleming, Mamede y la calibración de modelos de lenguaje).

Qué se solicita

Un prólogo de **800 a 1.200 palabras**, con **plazo flexible dentro de seis semanas** y **libertad total de contenido**, crítica incluida. El manuscrito completo se envía de inmediato a quien acepte considerar la invitación. Nombre del prologuista en portada e interiores.

Contacto: Daniel Opazo — [correo] — [teléfono]